

УДК: 616.661-006.6-08

Б.Т.Онгарбаев, Н.С.Нурғалиев, М.С.Косанов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Рак почки, осложненный тромбозом крупных магистральных сосудов

Аннотация. Актуальность проблемы лечения распространенных форм РП, говорят следующие факты: сосудистая инвазия отмечается у 5-10% больных.

За период с 2007 по 2012 год получили лечение 375 больных РП различных стадий. У 45 больных имело место наличие опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены (НПВ), что составляет 13,2% случаев.

Первичная и предоперационная диагностика опухолевого тромбоза почечных вен и НПВ у больных раком почки проводилась стандартными методами диагностики: УЗДГ сосудов, КТ (МСКТ) или МРТ. При выявлении опухолевого тромба при стандартном обследовании в дополнение проводилась селективная ангиографии сосудов с восходящей каваграфией с целью определения протяженности опухолевого тромба.

Во всех 45 случаях пациентам было выполнено радикальное хирургическое вмешательство - нефрэктомия с тромбэктомией: 14 случаев – на уровне почечных вен, 1 – вена надпочечника, 25 - тромбэктомия из НПВ при субпеченочном расположении тромба, 5 - при ретропеченочном расположении тромба.

Радикально выполненная операция дает шанс на продление жизни и выздоровление независимо от протяженности опухолевого тромба. С появлением эффективных методов лекарственного воздействия выделение групп различного прогноза может оказаться полезным для решения вопроса о назначении адъювантного лечения.

Ключевые слова: рак почки, опухолевый тромб

В мире ежегодно регистрируется 189,1 тыс. новых случаев рака почки (РП), что составляет 2,2% злокачественных новообразований у мужчин и 1,5% у женщин. Каждый год от этого заболевания погибает 91,1 тыс. пациентов (М.И. Давыдов, Б.П. Матвеев, 2000г.) О том, насколько актуальна проблема лечения распространенных форм, говорят следующие факты: сосудистая инвазия отмечается у 5-10% больных раком почки.

На сегодняшний день хирургическое вмешательство остается единственной возможностью продления жизни и улучшения ее качества у больных с распространенными формами рака почки, среди которых наиболее сложными являются пациенты с венозной опухолевой инвазией и распространением тромбов по почечной и нижней полой вене (НПВ), вплоть до правого предсердия. Нами проделан анализ хирургической деятельности больных раком почки, осложненным опухолевым тромбозом почечной и НПВ.

Материалы и методы

В отделении онкоурологии Казахского НИИ онкологии и радиологии в периоды наблюдения с 2007 по 2012 год получили лечение 375 больных раком почки различных стадий.

Из общего количества пациентов у 45 больных имело место наличие опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены, что составляет 13,2% случаев. Первичный опухолевый очаг локализовался в правой почке у больных с тромбозом значительно чаще (у 12 больных – 75%), левой почки – 4 больных (25%). Средний возраст оперированных больных 54,1 года, минимальный возраст 35 лет и максимальный возраст 84 года. На таблице показано распределение больных раком почки по годам, стадиям и соотношению опухолевого тромбоза.

Таблица 1 – Распределение больных РП по стадиям и наличию опухолевых тромбозов за период с 2007 по 2012 гг.

Годы	К-во больных	Стадия заболевания				опухолевый тромбоз
		I	II	III	IV	
2007-2008	102	19	21	43	19	8 (7,8%)
2009	55	6	14	30	5	8 (14,5%)
2010	56	8	12	21	15	13 (21%)
2011	72	17	16	23	13	10 (15%)
2012	90	28	25	19	18	6 (6%)
ВСЕГО	375	78	88	136	70	45 (13,2%)

Первичная и предоперационная диагностика опухолевого тромбоза почечных вен и НПВ у больных раком почки проводилась стандартными методами диагностики: УЗДГ сосудов, КТ (МСКТ) или МРТ. При выявлении опухолевого тромба при стандартном обследовании в дополнение проводилась селективная ангиографии сосудов с восходящей каваграфией с целью определения протяженности опухолевого тромба.

В 4 случаях опухолевый тромб не был диагностирован стандартными методами лучевой визуализации, наличие опухолевых тромбов в устье почечных вен, флотирующих в просвет НПВ было выявлено интраоперационно при ревизии НПВ.

Во всех 45 случаях пациентам было выполнено радикальное хирургическое вмешательство - нефрэктомия с тромбэктомией: 14 случаев – на уровне почечных вен, 1 случай – вена надпочечника, 25 случаев тромбэктомия из НПВ при субпеченочном расположении тромба, 5 случаев

при ретропеченочном расположении тромба. В 1 случае у больного имелся опухолевый тромб в ретропеченочном отделе, ниже уровня почечных вен имелся сформированный кровяной тромб. В связи с высоким риском тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде и невозможностью произвести тромбэктомию, а также учитывая наличие сформированного коллатерального кровотока больному произведена перевязка нижней полой вены ниже уровня отхождения почечных сосудов.

Результаты

В раннем послеоперационном периоде имелся ряд осложнений. В послеоперационном периоде умер 1 пациент, причина смерти острый ДВС – синдром. В 2 случаях имело место кровотечение из ложа опухоли в раннем послеоперационном периоде в сроки до 24 часов после операции, что потребовало повторной операции с целью остановки кровотечения.

Выводы

Хотя венозная инвазия ухудшает выживаемость больных раком почки, радикально выполненная операция дает шанс на продление жизни и выздоровление независимо от протяженности опухолевого тромба. С появлением эффективных методов лекарственного воздействия выделение групп различного прогноза может оказаться полезным для решения вопроса о назначении адъювантного лечения.

Түжырым

Б.Т. Оңғарбаев, Н.С.Нұрғалиев, М.С.Қосанов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Бүйректің қатерлі ісігі ірі тамыр жолдарының тромбоздарының асқынуы

Бүйректің қатерлі ісігінің жайылған түрін емдеу өзекті мәселе, келесі дәлелдердің айтуына тамыр инвазиясы – 5-10% науқастарда байқалды.

2007 мен 2012 жылдар аралығында әр түрлі сатыдағы 375 науқас бүйректің қатерлі ісігіне қарсы ем алды. 45 науқас бүйрек тамырындағы ісік тромбоздары оры алды, және төменгі жыныс тамырында 13,2% оқиганы құрады.

Алғашқы және операция алдындағы диагностика бүйрек тамырындағы тромбоз және НППВ бүйректің қатерлі ісігіне стандартты әдіспен диагностика жүргізілді: Тамыр УЗДГ, КТ (МСКТ) немесе МРТ. Тромба ісігі

анықталған соң стандартты зертеулер кезінде оған қосымша тамырдың селективті ангиографиясы, енгізу кавографиясы жүргізілді. Ісік тромбасының жайылу мәлішерін анықтау үшін.

Барлық 45 оқиғада науқастарға радикалды хирургиялық көмектер жүргізілді- нефрэктомия және тромбэктомиа: 14 оқиғада - бүйрек тамырына жүргізілді, 1- бүйрекбезі тамырына, 25- НВП тромбэктомиясына суббүйректік тромбасының орналасуы, 5-бүйректе бұрыннан бері орналасқан тромба.

Радикалды операцияны жүргізу өмірді ұзартуға, және ісік тромбасының созылуына карамастан жазылып кетуге мүмкіндік береді, әсерлі емнің пайдасы әр түрлі топтағы науқастарға дәрігермек әсерімен коса адьювантты емінің тигізер әсері мол.

Түйінді сөздер: Бүйректің қатерлі ісігі, ірі қантамырлардың тромбозы.

Summary

B. Ongarbaev, N.Nurgaliyev, M Kossanov

Kazakh Scientific Institute Oncology and Radiology

Kidney cancer is complicated by thrombosis of major trunk vessels

Topicality of the problem in the treatment of common forms of kidney cancer is marked vascular invasion in 5-10% of patients. In KazNIOiR for the period from 2007 to 2012 year 375 patients were treated at different stages of KC, of whom 13.2% (45) patients were the presence of tumor thrombosis of renal vein and inferior vena cava . Standard diagnosis of tumor thrombosis above veins in patients with kidney cancer is Doppler ultrasound of vessels, CT (MSCT) or MRI. In identifying this disease patients underwent selective angiography with a rising cavagraphy to determine the extent of the process. In all cases, 45 patients underwent radical surgery - nephrectomy with thrombectomy: at the level of the renal veins (14 cases), Vienna adrenal gland (1), thrombectomy of the VCI thrombus at subhepatic location (25) and retrohepatic location (5).

Radical surgery performed gives a chance to prolong life and no matter how long recovery process. With the advent of effective drug therapies may be useful for the decision on the appointment of adjuvant treatment.

Keywords: Kidney cancer, thrombosis of large vessels